EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 70215
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-09-04 09:58:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JOSE HUGO POBLETE HIDALGO			RUN	: 6.681.529-3
F.Nac	: 27-08-2023	Edad	: 0 AÑO	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-08-29	Fecha Egreso	: 2023-09-04 09:58:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Diagnósticos:
- ACV subagudo territorio limítrofe derecho ATE
- Traqueobronquitis día 3
- Tabaquismo activo.
- Hipotiroidismo descompensado
- Hipovitaminosis B12 en restitución
- Hipovitaminosis D
- Antecedentes: - Hipotiroidismo - Cardiopatía coronaria

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Antecedentes:
- Hipotiroidismo
- Cardiopatía coronaria
- Gonoartrosis
- Tabaquismo activo.

Diestro mRS 2
Consulta en SU del HSC el 27/08/23 traido por vecino al ser encontrado con cuadro de al menos 3 días de evolución consistente en debilidad de HC izquierdo. Se registró en DAU ingreso con FC 82 lpm, Sat 97%, PA 166/89 mmHg, T° 36.2°C. Al examen se describe disartria y hemiparesia izquierda. Se solicita estudio complementario con hipercolesterolemia, sin otras alteraciones de relevancia. Se hospitaliza y se solicitó angioTC de cerebro y cuello diferido. Se realizó el 28/08/23 angioTC de cerebro y cuello en que se constatan multiples hipodensidades parietotemporales derechas en territorio limítrofe e hipodensidades antiguas temporales y frontobasales bilateral posiblemente posttraumáticas. En fase angiográfica con suboclusión de segmento M2 posterior derecho.
Se toma conocimiento del caso el 29/08/23 paciente refiere al menos 2 semanas de debilidad de hemicuerpo izquierda progresiva. Sin cefalea, sin otras molestias.
En condiciones de alta, sin embargo sin red de apoyo familiar. Se solicita evaluación por dupla psicosocial.
Durante hospitalización cursa con aumento de sintomatología respiratoria y elevación de parámetros inflamatorios. Sin condensación, se considera traqueobronquitis, iniciando tratamiento antibiótico endovenoso con buena respuesta.

Se coordina con dupla psicosocial, para seguimiento en domicilio, que se concreta el día de hoy.
Se plantea alta con hospitalización domiciliaria para continuar tratamiento antibiótico.

PLAN DE MANEJO:

Estudio:
- Ecocardiograma TT ambulatorio

Tratamiento:
- Doble antiagregación y estatinas en dosis altas por 3 meses
- Restitución Levotiroxina
- Restitución VitB12
- Receta magistral Vitamina D 50.000 UI por semana por 6 semanas
- Completar tratamiento antibiótico en HODOM

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo 30 grados progresar por kine, asistido. Prevenir UPP. Contener en caso de necesidad.
2. Régimen blando hiposódico asistido a tolerancia.
3. Aspirina 100 mg, 1 comp al día, vía oral.
4. Atorvastatina 40 mg, 2 comp por noche, vía oral.
5. Clopidogrel 75 mg, 1 comp al día, vía oral.
6. Famotidina 40 mg, 1 comp al día, vía oral.
7. Levotiroxina 100 ug, 1 comp al día ayunas, vía oral.
8. Ceftriaxona 1 gramo, 2 FA al día por 4 días
9. Amlodipino 10 mg, 1/2 comp al día, Vía oral.
10. Isosorbide 10 mg, 1 comp cada 8 horas, vía oral.
11. Kinesiología motora y respiratoria
12. Fonoaudiología
13. Control en CAE neurología de HSC GES posterior a alta.
14. Control en servicio de urgencias en caso de necesidad. Se explican situaciones de reconsulta.

EXÁMENES Y RESULTADOS

Estudio complementario:
- 04/09/23 Creat 0.7, MDRD 111, ELP 139/3.6/106, PCR 40.6
- 02/09/23 Procalc 0.1
- 01/09/23 Glic 96, Creat 0.9, MDRD 83, ELP 140/3.6/106, Hb 15.2, Hto 42.7, Leuco 9900, Plaq 166.000, VHS 9, PCR 153. INR 1.21. TTPa 30. OC no inflamatoria. UC negativo.
- 29/08/23 Tropo 17.1, TSH 15.77, T4L 0.83, VitB12 94, VitD 14, RPR no reactivo. HbA1c 5.1
- 28/08/23 angioTC de cerebro y cuello en que se constatan multiples hipodensidades parietotemporales derechas en territorio limítrofe e hipodensidades antiguas temporales y frontobasales bilateral posiblemente posttraumáticas. En fase angiográfica con suboclusión de segmento M2 posterior derecho.
- 27/08/23 Glic 103, Creat 1.1, MDRD 65.99, Uremia 52, BUN 24, ELP 140/4.4/103, Hb 16.8, Hto 46.7, Leuco 10500, Plaq 195.000, PCR 13.4. BT/BD 1.7/0.26, GOT/GPT/GGT 32/20/35, FA 120. INR 1.07. TTPa 30. ColT 269, HDL 73, LDL 180, TGL 81. CK 521. Urocultivo polimicrobiano

OBSERVACIONES:

Ex neurológico al alta:
- Mental: Vigil, orientado en tiempo y espacio, inatento, sin alteración del lenguaje, disartria leve
- PC: pupila izquierda media, RFM +, CV conservado, OCM normal sin nistagmus, sensibilidad facial simétrica, PFC izquierda. Protruye lengua en linea media, paladar blando simétrico.
- Motor: Hemiparesia izquierda braqual M0, crural M2.
- Sensitivo: hipoestesia BC izquierda
- Cerebelo: sin hallazgos
- Signos meningeos negativos.

Christian Alejandro Norambuena Aguayo
MEDICO TRATANTE
16447719-3

JEFE SERVICIO